

Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Página 1 de 9

Información Paciente

Nombre : Jose Teran Torres
Edad : 57a 0m 22d
Dirección : Caleta Chucumata

Rut : 27.012.697-9
Fecha Nacto: 02/02/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2533457
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8852 3630

N° Epicrisis
473248

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 29/12/2025 22:47
Fecha Egreso : 24/02/2026 18:02

Días Estadía: 57

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

shock septico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

30/12/2025 02:49:23
J.Dubo
Ingresa REA
Masculino 56 años
MC: Disnea

A: VA permeable, protege, sin trauma, sin estridor
B: Ventila simétrico, apremiado, expande tórax, saturando 93% con Venturi 10 L
C: Taquicárdico, normotenso, SI>1, SD <2.2, sin mottling, llene capilar 3 seg
D: Conciente, ote, cooperador, moviliza 4 extremidades, HGT 500, pupilas isocoricas y reactivas
E: Sin fiebre, dolor torácico y abdominal leve, mal aspecto general

Antecedentes: DM2 NO IR
Niega alergias farmacologicas: Glibenclamida
qx; amigdalas
no hospitalizaciones previas.
Sin uso ATB previos
Hábitos tóxicos fumador

Anamnesis: tos y fiebre de 3 dias de evolución consulta en sapu por disnea progresiva, presenta vómitos con contenido hemoptoico, malestar general.

En APS se broncodilata, se maneja con antipirético y se deriva. HGT de 560.
somnoliento.

Al examen físico
Conciente, ote, cooperador
Mucosas rosadas secas
Deshidratación moderada
Corazon con rr2t sin soplo

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Página 1 de 9

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Pulmonar con mp (+) crepitos abundantes bilaterales, sibilancias escasas
Abdomen sensible, sin irritación peritoneal
EEl sin edema y sin signos de tvp
Sin mottling, sin alteración del llenado capilar

Diagnóstico
Sepsis de foco respiratorio
Hiperglicemia

Plan:
-Ceftriaxona + Azitro
-Monitorización
-VPP, volemicación, laboratorio
-HC I y II
-OC/UC
-Panel respiratorio

Melillan / Dubo

Paciente se hospitaliza
Cumple criterios de ley de urgencias

Diagnóstico: Cetoacidosis Diabética

30/12/2025 02:49:23
J.Dubo
MDU - REA
FI CASR 30/01

Paciente cursando con sepsis de probable foco respiratorio + CAD. Evoluciona desfavorablemente, con mala mecánica ventilatoria, tendiente a la hipotensión, somnoliento, con FA RVR debut, refractario a manejo con volumen y oxigenoterapia. Se decide SRI:

- Etomidato 30 mg + Rocuronio 150 mg
- Tubo 8.0 a 21 cm, tercer intento de segundo operador, Cormack 3
- Sedoanalgesia con Fentanilo + Midazolam

Cobertura antibiótica con Ceftriaxona + Azitromicina e imagen (TC TAP). Manejo de CAD. Presento a UPC.

30/12/2025 08:25:25
A.Barra
a-a-
aa
aa
aa

30/12/2025 10:53:15
N.Delgado
Farmacia Clínica

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Se inicia seguimiento, Paciente curzando infección de piel y partes blansa, adempas sepsis por Streptococcus spp, sin suceptibilidad definida + Klebsiella pneumonia no productora de metalocarbapenemasa, en tratamiento con Ampicilina sulbactam 3g cada 6 hrs hoy, además se inicia vancomicina dosis de carga 2g + 1g a las 12 horas. En urgencia se administra dosis de ceftriaxona + azitromicina.

Exámenes de Laboratorio 30/12/2025

Láctico 4.7, BT 2.01, FA 245, GGT 160, GOT 47, GPT 41, Ca 7.9, Crea 2.58, BUN 58.3, P 3.9, Glic 433, Mg 4.1, PCR 409.1, Na 144, K 3.74

pH 7.2, pCO2 46.1, pO2 57.5, HCO3 17.8

Con diuresis disminuida, 40 mL en 2 horas, presentando aKI KDIGO II, sin antecedentes de función renal alterada. Actualmente con doble vaso actico Norepinefrina + Vasopresina con meta SAS 1 -2 sedoanalgesia con fentanilo + midazolam

Se sugiere:

- Vancomicina dosis de carga 2g luego 1g a las 12 horas
- Dosis de mantención vancomicina 750 mg día infundidos en 3 horas.
- Mantener ampicilina/sulbactam en dosis actuales por hoy, evaluar con infectología cambio a ceftriaxona.
- Dosis de mantención de ampicilina/sulbactam 3g cada 12 horas desde el 31/12/2025

QF. Nicolás Delgado Rioseco

30/12/2025 15:35:44

B.Abarca

EVOLUCIÓN UPC C2

30/12/2025

José Teran Torres

27012697-9

56 años

FI CASR 29/12

FI UPC 20/12

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

1- Shock séptico, probable foco pulmonar vs cutáneo.

·Neumonía multifocal cavitada.

·FI 30/12: vancomicina + ampicilina/sulbactam.

·Obs fascitis necrotizante

2- Falla multiorgánica secundaria a sepsis:

·Falla respiratoria aguda: VMI 30/12.

·Falla hemodinámica: shock refractario / FA

·Falla medular: Trombocitopenia severa. Anemia leve. Linfopenia.

·Falla renal aguda: AKI KDIGO 2, de etiología multifactorial.

·Falla metabólica: Obs de cetoacidosis diabética (hiperglicemia + acidosis metabólica con anión gap elevado).

3- Bacteriemia por Klebsiella pneumoniae y Streptococcus spp.

4- Antecedentes mórbidos: Diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente.

TOMO CONOCIMIENTO DEL CASO: paciente con ant. de DM2 NIR, previamente autovalente con cuadro de 3 días de sensación febril y CEG. Ingres a SU en malas condiciones generales con diagnóstico de shock séptico de foco pulmonar por

Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Página 4 de 9

NAC cavitada con cetoacidosis agregada. Se interpreta sepsis de foco pulmonar asociado a descompensación aguda de diabetes mellitus. Evoluciona con aumento del trabajo respiratorio y conflicto hemodinámico asociado a FA RVR por lo que se decide IOT.

Ingresa a UCI para continuar manejo. A su ingreso se objetiva lesión perianal necrótica de bordes indurados con compromiso glúteo y escrotal que podría estar en contexto de gangrena de Fournier.

ACTUALMENTE:

Paciente grave. RASS -4.

Hemodinamia sostenida con NAD 0.6ug/kg/min + VP 0.05 UI/min + hidrocortisona.

Normocardico, afebril, conectado a VMI AC

Diu (+) x CUP. Dep (-)

LABORATORIO

30/12 10:26 Láctico 4.7 CK-T 701 ELP 149/3.04/112 Ca(i) 5 P 2.3 Mg 4.0 pH 7.22 PCO2 44 PO2 67 HCO3 18 Gradiente CO2 3

IMAGENOLÓGIA

30/12 TAC AP: Extensos cambios inflamatorios del peritoneo en la pelvis especialmente en situación periprostática y perivesical estos hallazgos pudiesen estar en contexto de una prostatitis - Cistitis, indispensable correlación clínica. Áreas hipodensas mal definidas en el parénquima prostático que pudiesen corresponder a pequeños abscesos en formación. Se sugiere controlar.

Engrosamiento difuso del escroto y cambios inflamatorios de la región perineal de aspecto inflamatorio con una imagen de ulceración a nivel del pliegue interglúteo.

No se observa enfisema de los espacios profundos descritos así como tampoco colecciones.

Cambios inflamatorios peripancreáticos en relación a la cabeza que se extiende en situación periduodenal y en el surco páncreas duodenal. Estos hallazgos pudiesen estar en contexto una etiología inflamatoria ¿ulcero péptica?. Indispensable correlación clínica.

CSV 9am PA 107/43 | 60 FC 100 FR 24 Sat 94% VMI AC FiO2 45%

CSV 3pm PA 100/50 | 64 FC 91 FR 28 Sat 98% VMI AC FiO2 60%

RASS -4 (Fenta/Mida)

Mucosas con hidratación límite, llene capilar 3 seg, MS 0 pts. Yugulares planas.

MP (+) crépitos +/- sin otros ruidos agregados.

FA paroxística, no logro auscultar soplos con fonendo de unidad.

Abdomen RHA +, blando.

Lesión necrótica en zona interglútea de aprox 3x3cm asociado a zona indurada en glúteo derecho de aprox 10x10cm de color oscuro, indurado.

Sin edema ni signos de TVP.

Hemodinámico: ingresa en shock refractario con req de NAD/VP + hidrocortisona para PAM 65-70 mmHg. PLAN: Monitorización invasiva. Titular DVA a la baja según evolución.

Respiratorio: IOT/VMI en contexto de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía cavitada grave. Vt 420, FR 26-28, Ti 0.7, PEEP 5, FiO2 45%, DP 13. PLAN: Alto volumen minuto para compensar trastorno ácido-base. VMI protectiva.

Infeccioso: Ingresa con diagnóstico de sepsis foco pulmonar, por elevación de PPII y TC Tx con neumonía multifocal cavitada, sin embargo, se objetiva lesión perianal necrótica con compromiso escrotal, TAC evidencia engrosamiento difuso del escroto y cambios inflamatorios de la región perineal de aspecto inflamatorio con una imagen de ulceración a nivel del pliegue interglúteo. Además de extensos cambios inflamatorios del peritoneo en la pelvis especialmente en situación periprostática y perivesical estos hallazgos pudiesen estar en contexto de una prostatitis - Cistitis. Áreas hipodensas mal definidas en el parénquima prostático que pudiesen corresponder a pequeños abscesos en formación.

Del estudio microbiológico cuenta con:

- 29/12: HC I y II (+) para cocos gram (+) con FilmArray (+) para KPN y streptococcus spp (P) susceptibilidad.

- 29/12: OC inflamatoria, UC (P)

- 30/12: PVR (-)

- 30/12: CAET (P)

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Página 4 de 9

Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Página 5 de 9

- 30/12: VIH NR

Plan: se conversa con QF clínico, se ajusta a Vancomicina + AMS hasta espera de susceptibilidad y amikacina en dosis de carga por foco prostático.

Quirúrgico: por sospecha de gangrena de Fournier, se solicita evaluación a Cx de turno, quienes estan de acuerdo con impresión. PLAN: pabellón de urgencia hoy.

Metabólico / Medio interno: Diabetes mellitus descompensada. Impresiona cetoacidosis diabética (aunque no cuento con cetonemia por no disponibilidad en HSR). Se inicia BIC de insulina en espera de cumplir criterios de resolución para suspensión y traslape a vía SC.

PLAN: Regimen cero. BIC insulina, se inició SG por HGT <250 con meta 155-200. Carga de K y bicarbonato.

Nefrológico: AKI KDIGO 2 (sin crea basal), etiología multifactorial. PLAN: Seguimiento función renal.

Cardiológico: FA 2ria a shock séptico. Ecoscopia sin disfunción miocárdica (hiperdinámico). PLAN: vigilancia clínica.

Profilaxis: AntiH2 (no cuento con stock de IBP) + Tromboprofilaxis farmacológica.

Abarca / Barra / Gárate / Molina
UPC

31/12/2025 11:45:02

H.Sagredo

RESIDENCIA CIRUGIA

Shock septico - Multiples focos

-Neumonia multifocal

- Abscesos prostaticos

- CAD

- Gangrena de fournier

Se ingresa a pabellon de urgencia para primer aseo quirurgico

Hallazgos:

Necrosis extensa de piel de region escrotal bilateral, testiculos vitales. En gluteo derecho escara necrotica de aprox 6x6 cm. Necrosis grasa que se extiende hasta plano muscular de gluteo derecho. No se identifican colecciones ni salida de secreción purulenta.

Se realiza resección de tejido necrotico a nivel gluteo y reseccion de piel escrotal bilateral

Intraoperatorio paciente con buena respuesta a la volemización con disminución progresiva de requerimientos de DVA, sale de pabellon con NAD 0.35

Plan:

Programar nuevo aseo quirurgico

Reanimación adecuada, lograr balances neutros o levemente positivos

Mantener ATB empirica

Rescatar rewsultado cultivo tomado en pabellon

Seguimiento por UTU y urologia

31/12/2025 17:46:10

B.Gárate

Evolución UPC C2 31/12/25

José Teran Torres, 56 años, 27012697-9

FI CASR: 29/12

FI UPC: 30/12

FI IOT: 30/12

AM: DM2NIR

ATB

Vancomicina 30/12 ->

Piperacilina/Tazobactam 31/12 ->

Laboratorio

Hb 10.9 (11.9) Hto 32.3 (36.7) GB 9.070 (5.750) RAN 7.300 RAL 1400 PLQ 30.000 (37.000) Láctico 3.3 (4.1) DCO2 3.3 SvO2 75.7 PCR 406.9 (409.1) PCT 262.9 Crea 3.64 (2.58) ELP 152/5.19/110 Mg 3.6 Cal 1.1 CaC 3.2 P 2.9 Amonio 0.92 Amilasa 161 CKT 764 CKMB 3.1 Glu 252 BT 5.26 (2.0) BD 3.88 (1.48) GOT 69 (47) GPT 32 (41) GGT 108 (160) FA 184 (245) LDH 595 INR 1.39 TTPK 35.2 GSA: pH 7.266 pCO2 32.9 pO2 68 HCO3 14.6 BE -11.1 SAT 91.3 PAFI 226 (FiO2 30%)

Diagnósticos

1) Shock séptico refractario de múltiples focos

a. Bacteriemia por Streptococcus bovis + KPN

b. Escara necrótica - Necrosis grasa Obs. Gangrena de Fournier

- POP de Aseo quirúrgico 31/12

c. Abscesos prostáticos

d. NAC ATS IV cavitada

2) SDOM

a. Disfunción circulatoria aguda

b. Insuficiencia respiratoria aguda parcial

c. AKI KDIGO III no oligúrica

d. Alteración de PPHH R-factor 0.5

e. Pancitopenia -> Anemia leve + Trombocitopenia severa

f. Obs. CAD -> Hiperglicemia + Acidosis metabólica + AG aumentado

3) Antecedentes

En conocimiento el caso. Paciente muy grave, se recibe durante la mañana con NAD a 0.66 + VSP 0.05 para metas de macrohemodinamia, con hiperlactatemia persistente. Febril hasta 40.2°C, anormalmente bradicárdico ~90, tendiente a la hipotensión principalmente diastólica, acoplado a VMI en AC/VC con TV 500, PEEPt 11 (10 + 1), DP 15, Pmax 35, Ti 0.7, FR 27 y FiO2 30 -> 50%.

Se traslada durante la mañana a pabellón para aseo quirúrgico, reingresa con NAD a 0.4 evolucionando rápidamente hasta 0.7 -> Ecoscopia con kissing walls, VTI 25, VCI 1.3, con PD (+). iSTAT con pH 7.26, pCO2 37.2, pO2 63 (PAFI 126), HCO3 16.7, Láctico 42. Se inicia Metamizol por fiebre, se cambia Ceftriaxona por Tazonam (principalmente por falta de susceptibilidad de KPN en sangre y mala cobertura anaerobia de CFT) y se indican 250 mL de bicarbonato al 2/3 M.

En régimen cero, con BIC de IC a 8 UI/hora para manejo de CAD. Diuresis (+) 760 cc/24 horas, deposiciones (-), SNG (+) 120 cc, BH (+) 4555 cc.

Examen físico

SV (15:00): T 38.0, FC 101, FR 27, PA 116/47 (66), SAT 93% con FiO2 50% x VMI x TOT

Invasiones: CVC (día 2), LA (día 2), TOT (día 2), SF (día 2), SNG (día 2)

- En SAS 1/2 con con BIC de Midazolam/Fentanilo. Isocoria hiporreactiva, mióticas.

- CRT < 3 segundos, tibio a distal, mottling score 0 puntos. Impresiona bien perfundido y con VEC levemente expandido.

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Página 6 de 9

Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Página 7 de 9

Yugulares ingurgitadas a 0°

- RR2TNAS. MP (+), crépitos finos bibasales.
- Abdomen RHA (+). Blando, depresible y sin reacción a la palpación profunda. Blumberg (-). Zona operatoria cubierta con apósito seco y limpio
- EEl sin edema ni otros signos de TVP.

Planes

- HDN: Shock séptico refractario, ya sin mayor tolerancia a volumen, con corticoides y DVA en dosis altas. Se decide HFAV
- Vent: VMI protectora aunque con requerimientos de O2 en aumento, control PM
- Infec: Múltiples focos, cobertura con Piperacilina/Tazobactam (previamente Ceftriaxona) y Vancomicina (por bovis). Una vez estable a definir ETE y posteriormente colonoscopia
- Nefro: AKI KDIGO III, se decide apoyar con HFAV por 24 horas
- Qx: POP de aseo quirúrgico, pendiente definir nuevo tiempo operatorio
- Nutri: Régimen cero
- Gastro: Alteración de PPHH sin alteración de INR, vigilar
- Hemato: Se Tx 7 U de PLQ intrapabellón, sin trigger al recontrol
- Neuro: Sedado con BIC de Fentanilo/Midazolam
- Profilaxis: Gástrica
- Social: Entrego información a familiar durante horario de visitas

Indicaciones

- HFAV
- Reanimación según monitoreo multimodal

NA
NA
NA

31/12/2025 17:49:14

B.Gárate

Nota UPC

Procedimiento: Instalación de CHD transitorio

Motivo: Shock séptico refractario, AKI KDIGO III

Descripción: Monitorización continua de signos vitales, asepsia y antisepsia, preparación de campos estériles. Cebo de CHD transitorio con SF 0.9%. Bajo visualización ecográfica continua se punciona VYID al primer intento. Se introduce guía y se confirma su presencia en vena mediante ecoscopia en eje corto y largo. Incisión pequeña con bisturí, se expande la piel con ambos dilatadores. Se introduce CHD transitorio hasta los XX cm. Ambos lúmenes refluyen e infunden con buenos flujos. Se fija con puntos simples a la piel y se cubre con apósito. Se termina el procedimiento sin incidentes. Solicito RxTx de control.

Dr. Gárate

NA
NA
NA

01/01/2026 13:38:16

A.Aquevedo

Se entrega información a familiar sobre estado de salud del paciente.

01/01/2026 13:41:21

A.Aquevedo

EVOLUCIÓN UCI

Nombre: JOSE TERAN TORRES Edad: 56 Años

3 ° día Hospitalizado

2 ° día UCI

3 ° día VMI

2 ° día CVC

1° día Cat HD

2 ° día ATB: tazonam + Vancomicina (Klebsiella pneumoniae en URO y Hemo + Estreptococo bobis en Hemocultivo)

Diagnósticos:

1) Shock séptico refractario de múltiples focos

a. Bacteriemia por Streptococcus bovis + KPN

b. Escara necrótica - Necrosis grasa Obs. Gangrena de Fournier

- POP de Aseo quirurgico 31/12

c. Abscesos prostáticos

d. NAC ATS IV cavitada

2) SDOM

a. Disfunción circulatoria aguda

b. Insuficiencia respiratoria aguda parcial

c. AKI KDIGO III no oligúrica

d. Alteración de PPH R-factor 0.5

e. Pancitopenia -> Anemia leve + Trombocitopenia severa

f. Obs. CAD -> Hiperglicemia + Acidosis metabólica + AG aumentado

3) Antecedentes

Paciente se mantiene muy grave Bajo sedación, intubado y conectado a VMI, HDN inestable. Requerimientos de NAD?: Si: ☒ / No: ☐. bajos: ☐ moderados: ☒ altos: ☐ de DVA para mantener una PAM > 65 mmHg. NAD: 0,23 ug/kg/min. + Vasopresina 0,01. Normocárdico: ☒ Taquicárdico: ☐ Bradicárdico: ☐. Ayer destaca: Afebril: ☐ Subfebril: ☐ Febril: ☒. Resto sin mayores cambios. Debe mantenerse en UCI.

EX FISICO: (Posición Supino: ☒ / Prono: ☐)

FC:

61

PA:

131/ 60

PAM:

82

T°C

36,2

FR:

27

SatO2 %

100

FiO2%

50

PIA: N/E PVC: N/E PIC: N/E PPC:N/E

Sedación?: Si: ☒ / No: ☐. Analgesia?: Si: ☒ / No: ☐. SAS 1. Pupilas isocóricas, mióticas. Reac

Diagnóstico de Egreso

Shock septico -

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Página 8 de 9

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:54

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 24-02-2026 18:41:52

Página 9 de 9

Condición de Egreso Fallecido
Fallece

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Andres Aquevedo Salazar
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 24/02/2026 18:41

Página 9 de 9

Fecha de Impresión : Miércoles, 25 de Marzo de 2026 23:54

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar